L'IPM calculé sur le RGPH 2021 au service du PND 2026-2030

Analyse d'alignement

Pipeline `PythonIPM`

Septembre 2026

Résumé

Ce document confronte l'indice de pauvreté multidimensionnelle calculé sur le Recensement général de la population et de l'habitation 2021 au Plan National de Développement 2026-2030. Il établit, cible par cible, ce que l'un permet de mesurer de l'autre, ce qu'il ne permet pas, et l'usage auquel il se prête le mieux. Un document jumeau traite de l'IPM calculé sur l'EHCVM 2021 ; un troisième les compare et conclut.

La conclusion en cinq lignes

- L'IPM RGPH couvre **sept des vingt-deux cibles** du PND qu'un indice de pauvreté peut mesurer — moins que l'enquête, faute de toute question de santé.
- Il est en revanche **le seul** à rendre opérationnels trois instruments centraux du plan : les **Pôles Économiques Compétitifs** du Pilier 5, le **registre social unifié** du Pilier 6 et le ciblage des **827 000 ménages** de filets sociaux du Pilier 4.
- Il publie un IPM pour **500 des 519 sous-préfectures et communes** et pour les **111 départements**, sans exception.
- Il établit que le milieu rural porte **84,7 %** de la pauvreté multidimensionnelle du pays pour 45,8 % de sa population.
- Étant décennal, il fournit **une photographie de départ**, pas un instrument de suivi : il ne dira pas en 2030 si le PND a produit ses effets.

Table des matières

1 Ce que le PND demande à un indice de pauvreté **2**

2 La correspondance, cible par cible **2**
2.1 Pilier 4 — Capital humain, compétences et emplois décents 3
2.2 Pilier 5 — Infrastructures, pôles régionaux et transition écologique 3
2.3 Piliers 2, 3 et 6 4

3 Ce que le RGPH est seul à apporter **4**
3.1 Une carte publiable partout 4
3.2 Le diagnostic territorial que le PND appelle 4
3.3 Le ciblage : du territoire au ménage 5
3.4 La mortalité, seule prise sur la santé 5

4 Ce que l'IPM RGPH ne peut pas faire pour le PND 6
4.1 La dimension Santé du Pilier 4 lui échappe entièrement 6
4.2 Le suivi dans le temps 6
4.3 Trois autres manques 6
4.4 Deux approximations à signaler 6

5 L'usage auquel l'IPM RGPH se prête 7

6 Limites de cette analyse 7

1 Ce que le PND demande à un indice de pauvreté

Le PND 2026-2030 vise à « Bâtir une Grande Nation Stable, Ambitieuse et Solidaire ». Parmi ses objectifs généraux figure de **« baisser significativement le taux de pauvreté »**, sans valeur cible à 2030 — seul objectif majeur à ne pas être chiffré.

Mais le plan ne demande pas seulement de *mesurer*. Trois de ses instruments supposent de savoir *où* et *qui*, à une maille que la statistique d'enquête n'atteint pas :

Pilier 5
: « renforcer la planification spatiale des investissements, fondée sur une **cartographie fine** des potentialités économiques régionales », développer les **Pôles Économiques Compétitifs** « à travers une répartition optimale et équitable » et aménager le territoire par les **villes secondaires** ;

Pilier 6
: instaurer un **registre social unifié** « visant à renforcer l'inclusion et le ciblage des politiques publiques », et poursuivre « le renforcement du processus de décentralisation et de réduction des inégalités régionales » ;

Pilier 4
: porter à **827 000** le nombre de ménages pauvres bénéficiaires de transferts monétaires au titre des filets sociaux.

Deux questions, pas une

Le PND pose au statisticien deux questions de nature différente. *Où en est-on, et où en sera-t-on en 2030 ?* — c'est une question de mesure. *Où faut-il investir, et quels ménages faut-il servir ?* — c'est une question de ciblage. Le recensement répond mal à la première et très bien à la seconde.

2 La correspondance, cible par cible

Les treize indicateurs de l'IPM RGPH se rapportent aux cibles du PND comme suit. La colonne « Aujourd'hui » donne la part de la population vivant dans un ménage privé sur l'indicateur.

2.1 Pilier 4 — Capital humain, compétences et emplois décents

Cible PND à 2030	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Analphabétisme adultes 51,1 → 45 %	Alphabétisation	70,4 %	directe
Analphabétisme 15-24 ans 37,6 → 20 %	Alphabétisation	70,4 %	directe
Achèvement 1er cycle secondaire 81,14 → 89 %	Année de scolarité (par le diplôme)	63,2 %	approchée
Chômage et main-d'œuvre potentielle (SU3) 12,9 → 8,9 %	Chômage	5,9 %	directe
Espérance de vie 62,3 → 65 ans	Mortalité dans le ménage	1,1 %	indirecte
827 000 ménages bénéficiaires des filets sociaux	**identification exhaustive des ménages pauvres**	—	**opérationnelle**
Enrôlés à la CMU 20 → 30 millions	—	—	**aucune**
Couverture par la protection sociale 27 → 50 %	—	—	**aucune**
Personnes à moins de 5 km d'un centre de santé 82 → 100 %	—	—	**aucune**
Retard de croissance des moins de 5 ans 21,4 → 18 %	—	—	**aucune**
Indice de l'écart genre 0,655 → 0,7	—	—	aucune
Préscolaire ; EFTP ; IPS primaire	—	—	aucune

2.2 Pilier 5 — Infrastructures, pôles régionaux et transition écologique

Cible PND à 2030	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Pôles économiques compétitifs, villes secondaires, réduction des inégalités régionales	**IPM à la maille de 519 sous-préfectures**	—	**opérationnelle**
Accès à une source d'eau améliorée 81 → 90 %	Eau potable (source seule)	14,3 %	directe
Accès à l'assainissement amélioré 37 → 70 %	Toilette (sans le partage)	45,1 %	directe
Accès universel à l'électricité d'ici 2030, en priorité dans les quartiers précaires	Électricité	11,5 %	directe
Habitat décent (défi no 5 du diagnostic)	Logement	25,0 %	directe
Population utilisant internet 40,7 → 60 %	Biens d'équipement	18,2 %	indirecte
Promiscuité, densité d'occupation du logement	—	—	aucune

2.3 Piliers 2, 3 et 6

Cible ou orientation PND	Indicateur IPM	Auj.	Prise
Registre social unifié pour le ciblage (P. 6)	**base exhaustive de 5,6 M de ménages**	—	**opérationnelle**
Enregistrement des naissances 56,6 → 100 % (P. 6)	Déclaration d'état civil	15,2 %	directe
NNI 27,78 → 100 % (P. 6)	Déclaration d'état civil	15,2 %	indirecte
Modernisation de l'agriculture et productivité (P. 2) ; réduction de l'informalité (P. 3)	Emploi agricole de subsistance (approché)	46,0 %	approchée
Énergie de cuisson propre (P. 5)	Énergie de cuisson	62,7 %	directe

Le décompte

Sur les vingt-deux cibles et orientations du PND qu'un indice de pauvreté peut éclairer, l'IPM RGPH en couvre **sept de façon directe**, deux par approximation, deux de façon indirecte, et en rend **trois opérationnelles** — le ciblage territorial, le registre social et la sélection des ménages bénéficiaires — que l'enquête ne peut pas servir du tout. Huit restent hors de portée, dont les quatre cibles santé et nutrition du Pilier 4.

3 Ce que le RGPH est seul à apporter

3.1 Une carte publiable partout

C'est l'apport décisif, et il se chiffre. Le tableau ci-dessous donne, pour chaque maille, le nombre de modalités dont l'IPM est trop imprécis pour être publié — convention usuelle : un coefficient de variation supérieur à 20 %.

Maille	Modalités	Non publiables	Population concernée
Ensemble	1	0	—
Milieu de résidence	3	0	—
Région	33	0	—
Département	111	0	—
Sous-préfecture ou commune	519	19	1,55 %

La maille du Pilier 5 est atteinte

Le recensement publie un IPM pour **les 111 départements sans exception** et pour **500 des 519 sous-préfectures et communes**. Les 19 restantes ne représentent que 1,55 % de la population, et leur imprécision tient au petit nombre de zones de dénombrement, non au nombre de ménages.
C'est exactement l'échelle à laquelle le Pilier 5 entend conduire sa « répartition optimale et équitable des investissements publics et privés ».

3.2 Le diagnostic territorial que le PND appelle

Le PND fait de la réduction des inégalités régionales une orientation du Pilier 6 et le rééquilibrage territorial l'objet même du Pilier 5. L'IPM RGPH en donne la mesure.

Milieu	Part pop.	H	M_0	Part de la pauvreté
Urbain	44,8 %	5,4 %	0,0212	5,7 %
Semi-urbain	9,4 %	41,0 %	0,1705	9,7 %
Rural	45,8 %	71,1 %	0,3075	**84,7 %**

Le rural et l'urbain pèsent le même poids démographique, et le rural porte quinze fois l'IPM de l'urbain. À l'échelle des régions, l'écart va de 0,0069 (District autonome d'Abidjan) à 0,3654 (Bounkani), soit un rapport de **un à cinquante-trois**. À l'échelle des sous-préfectures, il va de 0,0015 (Plateau) à 0,4752 (Santa de Ouaninou), où 92,6 % de la population est multidimensionnellement pauvre.

Le semi-urbain, angle mort de l'enquête

Le recensement distingue trois milieux là où l'EHCVM n'en code que deux. Le semi-urbain concentre la population **vulnérable** : 34,2 % de ses habitants ont un score de privation compris entre 0,2 et le seuil de pauvreté, contre 17,7 % en urbain et 20,9 % en rural.
Ce sont précisément les « villes secondaires » que le Pilier 5 entend développer. L'enquête ne permet pas de les isoler.

3.3 Le ciblage : du territoire au ménage

Le PND fixe un objectif de **827 000 ménages** bénéficiaires de transferts monétaires et prévoit un **registre social unifié**. Ces deux instruments demandent une base exhaustive.

L'IPM RGPH identifie **1 751 746 ménages multidimensionnellement pauvres**, chacun avec son score, son identifiant et sa localisation. L'objectif de 827 000 ménages représente donc **47 % des ménages pauvres** : le problème n'est pas d'en trouver assez, mais de choisir lesquels — ce qu'un score par ménage permet de faire par ordre de sévérité.

Statut	Ménages
Pauvreté sévère ($c_i \geq 0{,}5$)	285 115
Pauvres ($c_i \geq 1/3$)	1 751 746
Vulnérables ($0{,}2 \leq c_i < 1/3$)	1 155 195

Sur le plan géographique, **121 sous-préfectures concentrent la moitié** de la pauvreté multidimensionnelle du pays, pour 41,5 % de sa population, et 277 en concentrent 80 %. Une politique de ciblage géographique dispose là de sa liste de priorités.

3.4 La mortalité, seule prise sur la santé

Le recensement ne pose aucune question de santé, mais il recense les décès survenus dans le ménage au cours des douze mois précédents. L'IPM en tire son unique indicateur de santé : le décès d'un enfant de moins de 18 ans, qui touche **1,1 %** des ménages.

C'est la seule prise, même indirecte, sur la cible « espérance de vie de 62,3 à 65 ans ».

4 Ce que l'IPM RGPH ne peut pas faire pour le PND

4.1 La dimension Santé du Pilier 4 lui échappe entièrement

Quatre cibles chiffrées sans aucune prise

Le recensement ne permet de mesurer **aucune** des quatre cibles santé et nutrition du Pilier 4 : les 30 millions d'enrôlés à la CMU, la couverture par la protection sociale portée à 50 %, la population à moins de 5 km d'un établissement de santé portée à 100 %, et la prévalence du retard de croissance ramenée à 18 %.
Ce n'est pas une lacune de l'indice, c'est une propriété du questionnaire : un recensement administré à trente millions de personnes ne peut pas porter de module de santé.

La conséquence se lit dans la décomposition de l'indice. La dimension Santé, réduite à la seule mortalité, porte un quart du poids nominal et ne contribue qu'à **1,6 %** de M_0.

Dimension	**Poids nominal**	**Contribution à M_0**
Éducation	25 %	40,6 %
Conditions de vie	25 %	29,2 %
Emploi	25 %	28,6 %
Santé	25 %	**1,6 %**

4.2 Le suivi dans le temps

Une photographie, pas un film

Le RGPH est décennal. Le prochain n'interviendra pas avant la fin du PND 2026-2030. L'IPM RGPH fournit donc une **valeur de départ** très solide et très détaillée, mais ne pourra pas dire, à mi-parcours ni en 2030, si les cibles ont été atteintes.
Le PND prévoit un cadre de gouvernance chargé d'apprécier les progrès : le recensement ne peut pas l'alimenter en évolution.

4.3 Trois autres manques

Le genre.
Le sexe du chef de ménage n'est pas dans l'extrait transmis. La cible « indice de l'écart genre 0,655 → 0,7 » ne peut pas être éclairée par cet indice.

La pauvreté monétaire.
Le recensement n'a pas de module de consommation. L'objectif « baisser significativement le taux de pauvreté », que le PND documente sur la série monétaire, ne peut pas être croisé avec la pauvreté multidimensionnelle dans cette source.

La promiscuité.
Le nombre de pièces du logement n'est pas collecté, alors que le développement urbain et l'accès à un logement décent figurent parmi les dix défis du diagnostic stratégique du PND.

4.4 Deux approximations à signaler

Deux indicateurs reposent sur une substitution qu'il faut mentionner si le chiffre est publié dans un document du PND.

L'année de scolarité
: est mesurée par le *diplôme* le plus élevé — le BEPC ou plus vaut dix années accomplies — faute de question sur les années d'études ou la classe atteinte. L'approximation est bonne au niveau national (63,2 % contre 62,9 % à l'enquête), moins bonne individuellement.

L'emploi agricole de subsistance
: retient le chef de ménage occupé dans une branche agricole, à son compte ou comme aide familial, faute de question sur « son propre champ ». C'est le **premier contributeur à l'indice** (26,8 %) : l'approximation pèse lourd.

5 L'usage auquel l'IPM RGPH se prête

Trois emplois immédiats

1. **La carte de référence du Pilier 5.** Un IPM publiable pour 111 départements et 500 sous-préfectures, qui donne à la « planification spatiale des investissements » sa base statistique.
2. **Le socle du registre social unifié du Pilier 6.** 5,6 millions de ménages, chacun avec un score de privation, un identifiant et une localisation — dont 1,75 million de pauvres et 285 000 en pauvreté sévère.
3. **La liste de priorités des filets sociaux.** 121 sous-préfectures concentrent la moitié de la pauvreté du pays ; l'objectif de 827 000 ménages peut y être décliné par ordre de sévérité.

Il ne se prête en revanche pas au cadre de résultats du plan : sept cibles seulement, aucune sur la santé, et aucune possibilité d'actualisation avant 2030.

6 Limites de cette analyse

1. **Les correspondances ne sont pas des identités.** Les indicateurs de l'IPM sont des indicateurs de *ménage* ; les cibles du PND sont le plus souvent des taux *individuels*. Les deux évoluent dans le même sens sans être le même nombre.
2. **L'IPM RGPH n'est pas comparable en niveau à l'IPM EHCVM**, la dimension Santé du premier étant presque inerte. Toute comparaison entre les deux sources doit passer par la variante harmonisée.
3. **Un écart de taux de privation sur la toilette** (45,1 % ici, 33,09 % dans la production Stata antérieure) n'est pas réconcilié et reste à élucider avec l'INS.
4. **Les intervalles de confiance d'un recensement** ne mesurent pas une incertitude d'échantillonnage mais une dispersion entre zones de dénombrement. Le seuil de publication à 20 % de coefficient de variation reste une convention prudente, non une règle absolue.
5. **Le PND ne contient pas de cible d'IPM.** L'alignement établi ici est un alignement de *contenu*, pas une correspondance institutionnelle.